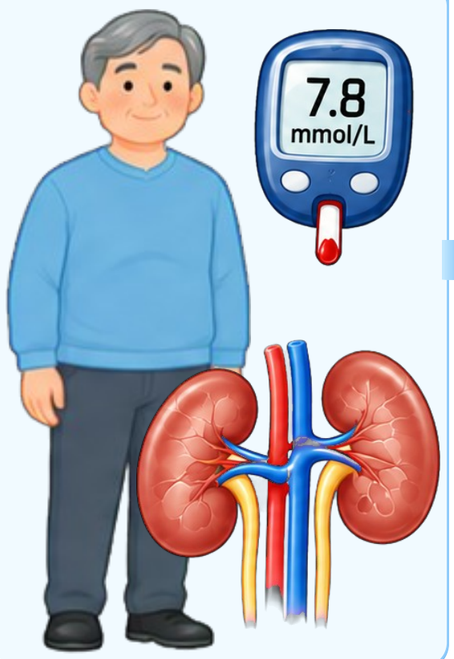
图 3　基于残余风险的心肾协同管理路径

1　2 型糖尿病 + 糖尿病肾病



2　基础评估

- eGFR
- 尿白蛋白 / UACR
- 心力衰竭风险
- 肥胖 /ASCVD 风险
- 血压与血脂

3　基础综合管理

- 个体化控糖
- ACEI/ARB
- 调脂
- 生活方式干预

4　基于残余风险的个体化强化治疗

A　eGFR 下降快或心衰风险高	优先考虑 SGLT2 抑制剂	延缓肾功能下降	降低心衰住院风险
B　肥胖或 ASCVD 风险高	考虑 GLP-1 受体激动剂	减重	降低动脉粥样硬化风险
C　尿白蛋白持续升高	可加用非奈利酮	进一步降尿蛋白	针对炎症 / 纤维化残余风险

5　动态随访与再评估

- 动态随访
- 监测血钾、 eGFR 、 UACR 、血压、体重 / 容量状态
- 必要时调整治疗或转诊

治疗目标：降低整体心肾风险，而非单纯叠加药物